

CARTILHA DE PSICOMOTRICIDADE

Movimento, desenvolvimento e aprendizagem na infância

SOULKIDS

EDIÇÃO COMERCIAL 2026

Renan Nascimento Martins Viana
Professor de Educação Física • Psicomotricista

Apresentação

Esta Cartilha de Psicomotricidade foi desenvolvida para aproximar famílias, responsáveis, educadores e profissionais do universo do desenvolvimento infantil, apresentando conceitos essenciais de forma acessível, tecnicamente responsável e aplicável ao cotidiano.

Desde os primeiros meses de vida, a criança utiliza o corpo como um dos principais meios para conhecer o mundo. Antes mesmo de falar ou escrever, aprende pelo olhar, toque, gestos, brincadeiras e experiências de movimento. Rolar, sentar, engatinhar, caminhar, correr, pular, equilibrar-se e manipular objetos participam da construção progressiva da autonomia, da aprendizagem, das relações sociais e da organização emocional.

A psicomotricidade compreende o desenvolvimento de maneira integrada, considerando as relações entre movimento, cognição, emoção e interação social. Sua atuação não se limita ao aprimoramento de habilidades motoras: busca favorecer participação, autonomia e funcionalidade nas brincadeiras, na escola, nas atividades cotidianas e nas relações.

Ao longo desta publicação serão abordados o papel do movimento no desenvolvimento infantil, o brincar com intencionalidade clínica, as abordagens Funcional/Instrumental e Relacional, a avaliação psicomotora, a elaboração do plano de intervenção, a participação familiar e alguns mitos frequentes sobre a área.

Psicomotricidade e movimento

O corpo como caminho para aprender

A psicomotricidade é uma área de conhecimento e intervenção voltada às relações entre corpo, movimento, cognição, emoções e interações sociais. A criança utiliza o corpo não apenas para se deslocar, mas também para explorar o ambiente, comunicar necessidades, expressar emoções, construir vínculos e aprender.

Durante um circuito motor, por exemplo, a criança pode precisar observar o ambiente, compreender a proposta, planejar movimentos, recordar uma sequência, controlar impulsos, adaptar-se aos obstáculos, encontrar soluções e lidar com erros e frustrações. Por isso, uma atividade motora raramente mobiliza apenas uma habilidade.

Movimento, aprendizagem e cotidiano

As experiências corporais podem envolver tonicidade, controle postural, equilíbrio estático e dinâmico, coordenação motora global e fina, coordenação óculo-manual e óculo-pedal, consciência corporal, lateralidade, organização espacial e temporal, ritmo e planejamento motor.

Também podem mobilizar atenção, memória de trabalho, controle inibitório, linguagem, comunicação, criatividade, regulação emocional, autonomia e interação social. Essas dimensões não devem ser interpretadas como relações causais simples: o desenvolvimento infantil é multifatorial.

Nem toda dificuldade escolar tem origem psicomotora. Entretanto, dificuldades persistentes de controle postural, coordenação, organização espacial, ritmo ou planejamento motor podem aumentar a demanda funcional de determinadas tarefas e justificar investigação profissional.

O brincar com intencionalidade clínica

Na intervenção psicomotora, o brincar pode ser utilizado com intencionalidade clínica. O profissional observa as necessidades e potencialidades da criança e organiza experiências coerentes com objetivos definidos. Algumas propostas são estruturadas e direcionadas; outras oferecem maior liberdade para iniciativa, expressão e criação.

O objetivo não é transformar toda brincadeira em exercício. A intervenção utiliza movimento, vínculo, ambiente e brincar para criar experiências significativas, graduadas e funcionalmente relevantes.

Psicomotricidade Funcional/Instrumental

A abordagem Funcional/Instrumental utiliza propostas mais estruturadas para trabalhar habilidades psicomotoras específicas. Circuitos, jogos, desafios motores, atividades de equilíbrio, coordenação, lateralidade, controle postural, consciência corporal, organização espacial, ritmo e planejamento motor podem ser graduados conforme a necessidade da criança.

Ao caminhar sobre uma superfície instável e depois arremessar uma bola em um alvo, por exemplo, a criança pode integrar ajuste postural, equilíbrio, coordenação óculo-manual, modulação de força, atenção e planejamento motor.

Psicomotricidade Relacional

A Psicomotricidade Relacional valoriza o brincar espontâneo, a comunicação corporal, os vínculos, as emoções e as relações estabelecidas durante a atividade. A forma como a criança ocupa o espaço, escolhe materiais, aproxima-se das pessoas, aceita limites, cria narrativas e reage às propostas pode oferecer informações relevantes ao processo clínico.

O brincar espontâneo não significa ausência de planejamento. O terapeuta organiza um ambiente seguro, observa, participa, estabelece limites e intervém de acordo com os objetivos e com as necessidades manifestadas pela criança.

Integração das abordagens

Funcional/Instrumental e Relacional possuem ênfases distintas, mas não precisam ser tratadas como abordagens concorrentes. Uma sessão pode combinar atividades estruturadas e momentos de maior espontaneidade, desde que a escolha seja clinicamente justificada.

A estratégia deve considerar perfil, interesses, nível de autonomia, contexto familiar e escolar, achados da avaliação e objetivos terapêuticos. Não existe uma abordagem universalmente superior para todas as crianças.

Avaliação e intervenção psicomotora

Compreender antes de intervir

A avaliação psicomotora busca compreender como a criança organiza corpo, movimento, atenção, participação e relações em diferentes situações. Além de identificar dificuldades, deve reconhecer potencialidades, interesses, estratégias e condições que facilitam ou limitam a participação.

O processo pode envolver entrevista com responsáveis, história do desenvolvimento, observação clínica, brincadeiras livres e dirigidas, atividades estruturadas, instrumentos apropriados à finalidade da avaliação, informações escolares e diálogo interdisciplinar.

Podem ser observados, entre outros aspectos, tonicidade, controle postural, equilíbrio, lateralidade, consciência corporal, organização espacial e temporal, coordenação global e fina, praxias, ritmo, planejamento motor, atenção, controle dos impulsos, comunicação, brincar, regulação emocional, interação social e autonomia.

Instrumentos padronizados devem ser utilizados e interpretados conforme sua finalidade, formação exigida, normas de aplicação e eventuais direitos autorais. Esta cartilha não reproduz protocolos, itens de teste, tabelas normativas ou sistemas de pontuação.

Sinais que merecem investigação

Nenhum sinal isolado determina diagnóstico. O desempenho pode variar conforme idade, compreensão da tarefa, motivação, ansiedade, cansaço, ambiente, oportunidades de experiência e outras condições.

Pode ser pertinente buscar avaliação quando dificuldades motoras ou psicomotoras são persistentes e produzem impacto funcional, por exemplo: quedas muito frequentes; dificuldade acentuada para correr, saltar, subir escadas ou aprender novas habilidades motoras; problemas importantes para arremessar, receber ou chutar uma bola; limitações no uso de lápis, tesoura, talheres ou botões; dificuldades de organização espacial ou corporal; evitação recorrente de brincadeiras motoras; ou dificuldades que prejudiquem autonomia e participação.

A interpretação deve considerar frequência, intensidade, persistência, contexto e impacto funcional. Quando necessário, a avaliação deve ocorrer de forma interdisciplinar.

Do resultado ao plano terapêutico

Após a avaliação, os objetivos devem ser individualizados, observáveis e relacionados às necessidades funcionais da criança. Podem ser organizados em curto, médio e longo prazo e revistos conforme a evolução.

O plano pode utilizar circuitos motores, brincadeiras corporais, jogos com regras, equilíbrio, arremessos e recepções, saltos, deslocamentos, ritmo, imitação, brincadeira simbólica, construção, encaixe, atividades gráficas, cooperação e estratégias de regulação, conforme indicação.

Uma mesma sessão pode integrar objetivos motores, cognitivos, emocionais e sociais. A seleção de atividades deve decorrer do objetivo terapêutico, e não apenas da disponibilidade de materiais ou da repetição de exercícios.

Evolução e participação da família

A evolução deve ser acompanhada continuamente por indicadores compatíveis com os objetivos definidos. Podem ser considerados qualidade do movimento, nível de ajuda necessário, compreensão e execução das propostas, participação, generalização das habilidades, autonomia, regulação e interação.

A família fornece informações essenciais sobre a rotina e pode observar mudanças que não aparecem durante a sessão. As orientações devem ser viáveis e contextualizadas, favorecendo oportunidades naturais de movimento, brincadeira, vínculo, participação e autonomia.

A casa não precisa se transformar em extensão rígida da clínica. O objetivo é aumentar oportunidades significativas no cotidiano, respeitando a dinâmica familiar e a segurança da criança.

Mitos e verdades

“Psicomotricidade é apenas brincar.” Mito. O brincar pode ser um recurso central, mas a intervenção profissional envolve avaliação, observação, planejamento, objetivos, tomada de decisão e acompanhamento da evolução.

“Toda brincadeira é uma intervenção psicomotora.” Mito. Brincar contribui para o desenvolvimento, mas uma intervenção exige intencionalidade profissional, objetivos definidos e acompanhamento.

“Psicomotricidade trabalha somente o motor.” Mito. O movimento é central, mas as situações psicomotoras podem envolver atenção, planejamento, comunicação, emoção, autonomia e interação.

“Ter um diagnóstico significa precisar de psicomotricidade.” Mito. A indicação deve decorrer das necessidades, achados da avaliação e impacto funcional, não apenas do nome de uma condição clínica.

“Existe uma abordagem melhor para todas as crianças.” Mito. Funcional/Instrumental e Relacional possuem ênfases diferentes; a escolha ou integração depende do caso.

“Resultados são imediatos quando a atividade é boa.” Mito. Evolução depende de múltiplos fatores, incluindo perfil da criança, complexidade das dificuldades, frequência, participação, oportunidades de prática e generalização.

Conclusão

O desenvolvimento infantil resulta da interação entre múltiplas dimensões. Na psicomotricidade, corpo e movimento constituem vias privilegiadas para observar e favorecer participação, aprendizagem, autonomia, expressão e relação.

Avaliar antes de intervir, definir objetivos individualizados, selecionar estratégias coerentes e acompanhar resultados são princípios centrais de uma prática responsável.

Funcional/Instrumental e Relacional podem oferecer recursos complementares quando utilizadas de acordo com as necessidades da criança.

Intervir precocemente, quando existe indicação, não significa apressar o desenvolvimento. Significa oferecer oportunidades adequadas e acompanhar de forma qualificada o percurso da criança.

SOULKIDS

Movimento, vínculo e desenvolvimento

Referências bibliográficas

- AUCOUTURIER, Bernard. O método Aucouturier: fantasmas de ação e prática psicomotora. São Paulo: Ideias & Letras, 2007.
- FONSECA, Vítor da. Manual de observação psicomotora: significação psiconeurológica dos fatores psicomotores. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
- FONSECA, Vítor da. Psicomotricidade: filogênese, ontogênese e retrogênese. 3. ed. Rio de Janeiro: Wak, 2009.
- LE BOULCH, Jean. O desenvolvimento psicomotor: do nascimento até 6 anos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.
- WALLON, Henri. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. Geneva: WHO, 2019. ISBN 978-92-4-155053-6.

Nota editorial

As referências acima sustentam conceitos gerais apresentados nesta edição. Antes de registro editorial formal ou impressão em grande escala, recomenda-se conferência catalográfica das edições citadas e atualização periódica da bibliografia.

Ficha técnica e direitos

Título	Cartilha de Psicomotricidade - Movimento, desenvolvimento e aprendizagem na infância
Elaboração	Renan Nascimento Martins Viana
Formação profissional	Professor de Educação Física
Área de atuação	Psicomotricidade
Projeto / marca	SoulKids
Edição	Comercial 2026
Local	Brasil

© 2026 Renan Nascimento Martins Viana / SoulKids. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, distribuída, armazenada ou disponibilizada comercialmente, integral ou parcialmente, por qualquer meio, sem autorização do titular dos direitos, ressalvadas as hipóteses legalmente permitidas.

Aviso profissional

Este material possui finalidade educativa e informativa. Não constitui diagnóstico, prescrição terapêutica individual, laudo, parecer ou substituição de avaliação realizada por profissional habilitado. Sinais e exemplos apresentados devem ser interpretados no contexto individual da criança e, quando necessário, em articulação com outros profissionais.

A menção a conceitos, autores ou instrumentos não autoriza a reprodução ou utilização de materiais protegidos. Protocolos, testes, escalas, tabelas normativas e sistemas de pontuação devem respeitar as regras de acesso, formação, aplicação e direitos autorais correspondentes.

Controle de imagens

Antes da comercialização, confirme que todas as ilustrações, fotografias, personagens, ícones e elementos gráficos utilizados na versão diagramada possuem autoria própria, licença comercial compatível ou autorização expressa de uso. Mantenha os comprovantes de licença e os arquivos de origem.

BRINCAR, MOVER, APRENDER E CRESCER

SoulKids

Renan Nascimento Martins Viana
Professor de Educação Física • Psicomotricista

*“O movimento é uma forma de a criança conhecer o mundo,
comunicar-se e construir autonomia.”*

SOULKIDS • MOVIMENTO, VÍNCULO E DESENVOLVIMENTO